

Comenzado el	domingo, 3 de marzo de 2019, 12:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 3 de marzo de 2019, 13:00
Tiempo empleado	16 minutos 1 segundos
Vencido	1 minutos 1 segundos
Puntos	0,00/15,00
Calificación	0,00 de 100,00

Pregunta **1**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 72 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina, el que cumple de manera irregular, es traído al servicio de urgencia, por compromiso de conciencia. Los familiares refieren que desde hace 2 días está con tos con expectoración mucopurulenta y fiebre, pero que hoy empezó a decir palabras sin sentido y luego presentó tendencia a dormir. Al examen está en sopor profundo, sin signos focales, con signos de deshidratación, FC: 106x', PA: 100/60 mmHg, T°: 38,7°C y saturación arterial de oxígeno de 96%. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones en la base izquierda. Sus exámenes muestran hematocrito: 49%, blancos: 16.000 por mm3, plaquetas: 400.000 por mm3, glicemia 816 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 4,0 mEq/L, pH: 7,38 y bicarbonato: 23 mEq/L. La radiografía de tórax portátil muestra signos de condensación en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato por vía endovenosa
- ☐ b. Administrar 1 litro de suero glucosado al 5% + 2g de NaCl + 1g de KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos endovenosos
- ☐ c. Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa
- ☐ d. Administrar 1 litro de suero glucosado al 5% + 2g de NaCl + 1g de KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato y antibióticos endovenosos
- ☐ e. Administrar 1 litro de suero fisiológico, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa

Tiene un síndrome hiperglicémico hiperosmolar (glicemia mayor a 600 mg/dl y osmolaridad plasmática mayor a 320 mOsm/L; si bien no dan la osmolaridad, en general toda glicemia sobre 600 tiene además osmolaridad sobre 320 y la clínica es compatible: compromiso de conciencia, deshidratación). Se trata con suero fisiológico, como primera medida. Además, requiere de insulina cristalina endovenosa, siempre y cuando el K+ sea mayor a 3,2 mEq/L. También requiere K+ endovenoso en goteo (1g de KCl si el K+ está sobre 3,2; y 3g, si está bajo 3,2; aunque no se da, si el K+ es mayor a 5,0 mEq/L). Por regla general, el Sd. HGHO no requiere bicarbonato. Quien sí requiere bicarbonato es la cetoacidosis diabética y solo si el pH es menor a 6,9. Finalmente se debe tratar la causa de la descompensación, en este caso la neumonía, la que requerirá ceftriaxona endovenosa (por tratarse hospitalizado).

La respuesta correcta es: Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa

Pregunta **2**
Sin contestar
Puntúa como 1,00

Un paciente diabético tipo 1, presenta un cuadro de desorientación y luego convulsiones, que fue precedido por palpitaciones y temblor de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- ☐ a. Mielinolisis pontina
- ☐ b. Accidente vascular encefálico
- ☐ c. Encefalopatía de Wernicke
- ☐ d. Cetoacidosis diabética
- ☐ e. Hipoglicemia

Es una hipoglicemia clásica: síntomas simpaticomiméticos (palpitaciones y temblor), seguidos de síntomas neuroglucopénicos (convulsiones y compromiso de conciencia).

La mielinolisis pontina es un cuadro grave, asociado a la corrección rápida de la hiponatremia, con suero hipertónico. Se caracteriza por compromiso de conciencia y tetraparesia.

El AVE se caracteriza por signos focales de inicio súbito.

La encefalopatía de Wernicke se caracteriza por el COCA (confusión, oftalmoparesia, coma y ataxia) y se debe al déficit de tiamina (vitamina B1), generalmente en pacientes alcohólicos o muy desnutridos.

La cetoacidosis sí puede tener compromiso de conciencia, pero se caracteriza por polipnea, fétor a manzana, dolor abdominal, náuseas y clínica de DM descompensada (poliuria, polidipsia, etc).

La respuesta correcta es: Hipoglicemia

Pregunta **3**
Sin contestar
Puntúa como 1,00

¿Cuál de los siguientes pacientes tiene diagnóstico de diabetes mellitus?

Seleccione una:

- ☐ a. Paciente asintomático, con glicemia de ayuno de 290 mg/dl
- ☐ b. Paciente con glicemia de ayuno de 198, que se repite a los dos días, resultando 138
- ☐ c. Paciente con test de tolerancia a la glucosa, con glicemia basal de 110 mg/dl, que llega a los 180 mg/dl a las 2 horas postingesta de 75 gramos de glucosa
- ☐ d. Paciente con hemoglobina glicosilada de 6%
- ☐ e. Paciente con un hemoglucotest de 400 mg/dl

La A tiene una glicemia sobre 200, pero le faltan los síntomas.

La B cumple con el criterio de 2 glicemias mayores o iguales a 126 mg/dl, así que está hecho el diagnóstico.

La C tiene una glicemia alterada de ayuno (basal entre 100 y 125) y además una intolerancia a la glucosa oral (postcarga entre 140 y 199).

La D está normal. Hoy se acepta que la HbA1c mayor o igual a 6,5% es diagnóstica, pero en Chile no se utiliza ese criterio y la HbA1c solo se usa como el examen de elección para el seguimiento de la diabetes y no para su diagnóstico.

La E no puede ser utilizada, porque el hemoglucotest no es un examen aceptado para el diagnóstico de diabetes. Por lo que debe solicitarse las glicemias venosas.

La respuesta correcta es: Paciente con glicemia de ayuno de 198, que se repite a los dos días, resultando 138

Pregunta **4**
Sin contestar
Puntúa como 1,00

El hipotiroidismo suele presentar la siguiente alteración en el perfil lipídico:

Seleccione una:

- ☐ a. Colesterol LDL aumentado
- ☐ b. Colesterol HDL aumentado
- ☐ c. Colesterol HDL bajo
- ☐ d. Triglicéridos aumentados
- ☐ e. Colesterol LDL pequeño y denso

EL hipoT4 se asocia a LDL aumentado. En cambio, la diabetes se asocia a HDL bajo, TG aumentados y LDL pequeño y denso (que es más aterogénico que el LDL común y corriente).

La respuesta correcta es: Colesterol LDL aumentado

Pregunta **5**
Sin contestar
Puntúa como 1,00

Un paciente diabético tipo 1, en tratamiento con insulina es esquema intensificado con dos dosis de insulina NPH y tres refuerzos con insulina cristalina, presenta los siguientes controles promedio con Hemoglucotest:

Predeayuno: 150	Postdeayuno: 170
Prealmuerzo: 90	Postalmuerzo: 120
Precena: 80	Postcena: 100

La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
- ☐ b. Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna
- ☐ c. Aumentar la dosis de insulina cristalina predeayuno
- ☐ d. Aumentar la dosis de insulina cristalina prealmuerzo
- ☐ e. Aumentar la dosis de insulina cristalina precena

La glicemias preprandiales dependen de la insulina lenta (glargina o NPH) recibida hace varias horas atrás (ej. la de ayuno depende de la NPH nocturna). En cambio, las glicemias postprandiales dependen de la insulina rápida (ultrarrápida o cristalina), aunque también dependen de la glicemia preprandial y de la comida misma.

En este caso, las glicemias predeayuno y postdeayuno son las que están elevadas, por lo que se debe aumentar la insulina NPH nocturna, para normalizar la glicemia predeayuno, lo que a su vez normalizará la postdeayuno.

Recordar que el objetivo de glicemias es preprandiales menores a 100 mg/dl y postprandiales menores a 130 mg/dl, pero que lo más importante es la hemoglobina glicosilada menor a 7%, así que si estuviera normal (lo que no se muestra en la pregunta), lo correcto sería mantener el tratamiento.

La respuesta correcta es: Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna

Pregunta **6**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente indigente, en situación de calle, ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de desorientación y dificultades para caminar. Al examen físico se constata estrabismo divergente, por parálisis del tercer nervio craneal izquierdo, ataxia de la marcha y desorientación temporoespacial, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoglicemia
- ☐ b. Hipofosfemia
- ☐ c. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- ☐ d. Encefalopatía de Wernicke
- ☐ e. Encefalopatía de Korsakoff

Es una encefalopatía de Wernicke clásica, causada por déficit de tiamina (vitamina B1) y muy frecuente en los pacientes alcohólicos, que de hecho deben recibir la tiamina de manera profiláctica. Su diagnóstico es clínico y se caracteriza por el COCA (coma, oftalmoplejía, confusión y ataxia de la marcha).

La hipoglicemia produce síntomas simpáticos/adrenérgicos (palpitaciones, sudoración, temblor), seguidos de síntomas neuroglucopénicos (convulsiones, compromiso de conciencia).

La hipofosfemia produce un cuadro de compromiso de conciencia, con rabdomiólisis y anemia hemolítica.

La encefalopatía de Korsakoff también es por déficit de B1, aunque es crónica y por daño permanente en los centros de la memoria, por lo que produce un cuadro de alteración de la memoria de corto plazo, pero también de largo plazo, lo que se caracteriza por la "confabulación", es decir, por rellenar los vacíos de la memoria con historias inventadas.

La respuesta correcta es: Encefalopatía de Wernicke

Pregunta **7**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 500 mg cada 8 horas, acude a control. Trae una hemoglobina glicosilada de 6,3% y una proteinuria de 24 horas en 200 mg/dl. Sin embargo, refiere que desde que inició la metformina, presenta diarrea y dolor abdominal ¿Cuál es la conducta más adecuada para el control metabólico de este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener la metformina y hacer hincapié en el cumplimiento de la dieta
- ☐ b. Aumentar la dosis de metformina a 850 mg cada 8 horas
- ☐ c. Agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
- ☐ d. Reemplazar la metformina por rosiglitazona
- ☐ e. Reemplazar la metformina por glibenclamida

Tiene un buen control metabólico (HbA1c menor a 7%), por lo que está bien tratada su diabetes. Sin embargo, la diarrea y el dolor abdominal son parte de los efectos adversos clásicos de la metformina, por lo que es recomendable suspenderla y reemplazarla por otro fármaco. Antes, la metformina se reemplazaba por glitazonas (tiazolinedionas), ya que ambas actúan disminuyendo la resistencia a la insulina, pero actualmente están obsoletas, por aumentar el riesgo cardiovascular. Por ello, de las opciones, la más aceptable es cambiarla por glibenclamida, aunque en estricto rigor, es mejor cambiarla por sitagliptina u otro DPP4.

En cambio, cuando es la glibenclamida la que produce efectos adversos (normalmente hipoglicemias), se suele reemplazar por DPP4 sin mayores dudas.

La respuesta correcta es: Reemplazar la metformina por glibenclamida

Pregunta **8**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Una paciente de 12 años, diabética tipo 1, en tratamiento con insulina, es traída al servicio de urgencia, por compromiso de conciencia. Los familiares refieren que desde hace 2 días está cursando con una infección urinaria, pero que hoy empezó a decir palabras sin sentido y luego presentó tendencia a dormir. Al examen está en sopor profundo, deshidratada, FC: 100x', PA: 90/60 mmHg, T°: 38,7°C y saturación arterial de oxígeno de 98%. Al examen pulmonar se aprecia polipnea. Sus exámenes muestran, glicemia 416 mg/dl, cetonas +++ en orina, sodio: 130 mEq/L, potasio: 4,6 mEq/L, pH: 7,18 y bicarbonato: 13 mEq/L. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato por vía endovenosa
- ☐ b. Administrar suero glucosado al 5% + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa
- ☐ c. Administrar suero fisiológico + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa
- ☐ d. Administrar suero glucosalino + KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato endovenoso
- ☐ e. Administrar suero fisiológico + bicarbonato e iniciar insulina endovenosa

Tiene una cetoacidosis diabética ya diagnosticada (cuerpos cetónicos positivos, acidosis metabólica, glicemia menor a 7,3), con la clínica característica. Como está normal el K⁺ está indicada la insulina y el K⁺. Y como el pH está sobre 6,9, no requiere bicarbonato.

La primera medida debe ser el suero fisiológico (o ringer) 20 cc/Kg de peso. Luego se inicia insulina y potasio, aunque no se debe dar insulina si hay hipopotasemia, ni se debe dar potasio si hay hiperpotasemia (por eso siempre se espera el resultado del potasio, antes de iniciar la insulina y el potasio. Además, se debe dar bicarbonato de sodio, pero solo si el pH es menor a 6,9 (si es mayor, la misma insulina normaliza el pH, al hacer desaparecer los cetoácidos).

La respuesta correcta es: Administrar suero fisiológico + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa

Pregunta **9**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente diabético tipo 1, presenta un cuadro de desorientación y luego coma, que fue precedido por marcado malestar general, náuseas y dolor abdominal. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- ☐ b. Encefalopatía de Korsakov
- ☐ c. Encefalopatía de Wernicke
- ☐ d. Cetoacidosis diabética
- ☐ e. Hipoglicemia

Es una cetoacidosis clásica: diabético 1, con síntomas abdominales (dolor y náuseas/vómitos), que luego evoluciona a compromiso de conciencia, polipnea. Los demás cuadros clínicos ya fueron explicados en otras respuestas.

La respuesta correcta es: Cetoacidosis diabética

Pregunta **10**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 58 años, obeso, presenta un perfil lipídico con triglicéridos de 210 mg/dl, colesterol LDL: 180 mg/dl, colesterol HDL: 35 mg/dl y colesterol total: 257. Se inicia dieta y ejercicios y se controla tres meses después, sin lograr cambios. Su glicemia de ayunas es de 110 mg/dl y su TTGO resulta 150 mg/dl a las 2 horas postcarga de glucosa. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar una estatina y metformina
- ☐ b. Iniciar un fibrato y metformina
- ☐ c. Iniciar un fibrato y una estatina
- ☐ d. Iniciar metformina
- ☐ e. Mantener las indicaciones

Tiene varios diagnósticos: 1. Hipertrigliceridemia, 2. Hipercolesterolemia LDL, 3. HDL bajo, 4. Glicemia de ayuno alterada (GGA), 5. Intolerancia a la glucosa oral (IGO), 6. Obesidad y 7. Síndrome metabólico.

Respecto a las [dislipidemias](#), la prioridad es el LDL, porque los TG están bajo 500, por lo que se debe iniciar estatinas.

Respecto al síndrome metabólico y a la GAA e IGO, todos se tratan con dieta y metformina.

Recordemos los criterios diagnósticos del síndrome metabólico: al menos 3 de los siguientes: obesidad abdominal, HTA, hiperTG, HDL bajo, patologías derivadas de la resistencia a la insulina (GAA, IGO o DM2).

No incluye alteraciones del LDL, que no se afecta cuantitativamente en la resistencia a la insulina, aunque sí se puede afectar cualitativamente, al volverse pequeño y denso y por tanto, más aterogénico.

La respuesta correcta es: Iniciar una estatina y metformina

Pregunta **11**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg/8 horas y glibenclamida 5 mg en la mañana, acude a control, constatándose creatinina 1,0 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 7,5%. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Reemplazar la metformina por una glitazona
- ☐ b. Subir la dosis de glibenclamida
- ☐ c. Iniciar insulina
- ☐ d. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- ☐ e. Solicitar un test de tolerancia a la glucosa oral

El control metabólico es insuficiente (HbA1c mayor a 7%), por lo que se debe avanzar en el tratamiento. No tienen ninguna indicación de insulina, ni contraindicaciones para los hipoglicemiantes orales. Dado que la metformina está en dosis elevadas, ya no se debe subir (en teoría se podría subir a 1g cada 8 horas, pero 850 mg es una dosis casi equivalente). La glibenclamida aún se puede subir, ya que la dosis máxima es 10 mg cada 12 horas.

La respuesta correcta es: Subir la dosis de glibenclamida

Pregunta **12**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina en dosis máximas, acude a control. Presenta hemoglobina glicosilada de 6,8% y glicemias de ayuno entre 90 y 120 mg/dl. Su examen físico es normal y el resto de sus exámenes son normales. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar insulina NPH
- ☐ b. Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- ☐ c. Suspender los hipoglicemiantes orales e iniciar insulina en esquema intensificado
- ☐ d. Mantener el tratamiento
- ☐ e. Agregar rosiglitazona al tratamiento

Está bien controlado (HbA1c menor a 7%), por lo que no es necesario hacer ningún cambio. Que las glicemias de ayuno estén mayores a 100 mg/dl, no importa, mientras se mantenga el objetivo de la hemoglobina glicosilada.

La respuesta correcta es: Mantener el tratamiento

Pregunta **13**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Un paciente de 45 años, con antecedente de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento con prednisona, presenta glicemia de ayuno 180mg/dl y glicemias postprandiales sobre 210 mg/dl, siendo diagnosticada de diabetes mellitus. ¿Cuál es el tratamiento inicial en esta paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Metformina
- ☐ b. Glibenclamida
- ☐ c. Pioglitazona
- ☐ d. Sitagliptina
- ☐ e. Insulina

Es una diabetes asociada a uso de corticoides, con glicemias arriba de 200mg/dl, por lo que el tratamiento de elección es la Insulina.

La respuesta correcta es: Insulina

Pregunta **14**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo, presenta un cuadro de cetoacidosis diabética. No presenta antecedentes familiares de diabetes, sin antecedentes de importancia. Al examen físico, se encuentra IMC de 20,5.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- ☐ a. Diabetes mellitus 1
- ☐ b. Diabetes mellitus 2
- ☐ c. Diabetes mellitus LADA
- ☐ d. Diabetes mellitus MODY
- ☐ e. Cetoacidosis congénita

La cetoacidosis hace pensar tanto en diabetes mellitus 1 y LADA: ambas son autoinmunes y bastantes severas. El antecedente de hipotiroidismo hace pensar en una causa autoinmune. El peso normal hace muy poco probable que sea una DM2 (dado que es adulto la primera sospecha siempre es una DM2).

La respuesta correcta es DM LADA, que es autoinmune de aparición tardía. Si hubiese sido un niño, la respuesta hubiera sido DM1. Si es que hubiese sido obeso, sería una DM2. La diabetes MODY, es una diabetes genética, de buen pronóstico, característica de los niños, con resistencia a la insulina de causa genética (similar a la DM2, pero de los niños).

La respuesta correcta es: Diabetes mellitus LADA

Pregunta **15**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Paciente de 28 años, con diagnóstico de anorexia, desnutrida, que pesa 45 kilos y mide 1,75 metros, es hospitalizada para inicio de su alimentación por sonda nasogástrica, recibiendo una dosis de 2.000 calorías al día, en el primer día. Inicia con arritmia ventricular por torsión de puntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- ☐ a. Déficit de vitamina B1
- ☐ b. Déficit de vitamina B12
- ☐ c. Síndrome de realimentación
- ☐ d. Hipercalcemia
- ☐ e. Hipoglicemia severa

El síndrome de realimentación, produce depleción aguda de oligoelementos, lo que se traduce en hipomagnesemia, hipocalemia e hipocalcemia, todo lo que alarga QT , produciendo torsión de puntas. Además, puede cursar con déficit de B1, hipofosfemia, baja aguda de zink, cobalto, etc. La causa es una alimentación agresiva en un paciente crónicamente desnutrido. Por ello, la alimentación debe iniciarse con apenas 10 Kcal por Kg de peso al día (450 Kcal en este caso), más aporte de oligoelementos y subirse de a poco.

La respuesta correcta es: Síndrome de realimentación

[◀ Cuestionario Diabetes 1.1](#)

Ir a...

[Cardiopatía congénita / Soplo cardíaco ▶](#)